



El Gobierno aprueba el primer reglamento de accesibilidad cognitiva, el COP Asturias publica una guía de primeros auxilios psicológicos para el ámbito escolar y la APA revisa la relación entre el sueño y la salud mental: claves del 2 de septiembre de 2026

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Resumen rápido del día

El Consejo de Ministros ha aprobado el primer reglamento de accesibilidad cognitiva de España, que obliga a nueve ámbitos a ofrecer información en formatos comprensibles. El Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias ha publicado una guía de intervención en emergencias escolares centrada en el protocolo R.E.S.C.A.T.E. de primeros auxilios psicológicos. Un amplio artículo de Monitor on Psychology, de la APA, revisa la relación bidireccional entre el sueño y la salud mental. Y un estudio publicado en Psicothema valida una nueva estructura de dos factores para el Montreal Cognitive Assessment en población española.

Noticias nacionales

NORMATIVA · NACIONAL

El Gobierno aprueba el primer reglamento de accesibilidad cognitiva de España

El Consejo de Ministros aprobó el martes 1 de septiembre el primer reglamento de accesibilidad cognitiva de España, una norma impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con la que el Gobierno da cumplimiento a la disposición adicional segunda de la Ley 6/2022 de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que desde hacía cuatro años obligaba a fijar unas condiciones básicas de accesibilidad cognitiva en todo el territorio. El real decreto establece que toda información y comunicación dirigida a la ciudadanía debe ser fácil de comprender y ofrecerse en formatos accesibles –lenguaje claro, lectura fácil, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, sonido, pictogramas, apoyos visuales o recursos tecnológicos–, sin coste adicional y sin retrasos. La norma tiene un enfoque universalista: se dirige a personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral, así como a personas mayores con deterioro cognitivo, personas en situación de analfabetismo y migrantes que no dominan las lenguas del Estado. El reglamento identifica nueve ámbitos esenciales de aplicación, entre ellos las telecomunicaciones, los espacios públicos, los transportes, los bienes y servicios –incluidos los sanitarios– y las relaciones con las administraciones públicas y la justicia. El Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG) trabaja ya en guías para facilitar su aplicación. La norma será exigible una vez se publique en el BOE, previsto en los próximos días. La entidad Plena Inclusión ha celebrado la aprobación, aunque reclama una partida presupuestaria suficiente para que las obligaciones puedan cumplirse de forma efectiva.

Fuente: Moncloa.com

CLÍNICA · NACIONAL

Una guía del COP Asturias sistematiza los primeros auxilios psicológicos en el ámbito escolar

La Comisión de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes del Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias ha publicado la Guía de

intervención psicológica en emergencias en el contexto escolar, dirigida a profesionales del ámbito educativo y de la intervención en emergencias. El documento se estructura en tres bloques: los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), el abordaje del duelo tras el fallecimiento de un miembro de la comunidad educativa y la comunicación de malas noticias a niños, niñas y adolescentes. La guía define los PAP como una intervención breve y basada en la evidencia, orientada a proporcionar apoyo inmediato y contención emocional a personas expuestas a un suceso potencialmente traumático –accidentes, incidentes de violencia o acoso, fallecimientos, desastres naturales o conductas suicidas, entre otros–, y aclara que no constituyen una terapia psicológica sino una primera respuesta de estabilización. Su principal herramienta práctica es el protocolo R.E.S.C.A.T.E., diseñado por Jesús Rivero, que organiza la intervención en siete pasos: revisión y preparación del entorno, entrada y escucha activa, serenar y estabilizar a la persona afectada, categorizar sus necesidades, ofrecer asistencia práctica y conexión con su red de apoyo, transmitir pautas de afrontamiento con contenido psicoeducativo y, por último, enlace y cierre, con evaluación del riesgo y derivación a servicios especializados cuando sea necesario. La guía subraya que aplicar los PAP requiere formación y entrenamiento específicos, e incluye recomendaciones concretas sobre qué hacer y qué evitar durante la intervención.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España)

Noticias internacionales

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

La APA revisa la evidencia sobre la relación bidireccional entre el sueño y la salud mental

Un amplio artículo publicado en *Monitor on Psychology*, la revista de la Asociación Americana de Psicología (APA), revisa la evidencia científica reciente sobre la relación entre el sueño, el funcionamiento cerebral y la salud mental. El trabajo recoge que los problemas de sueño, lejos de ser únicamente una consecuencia de trastornos como la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, la esquizofrenia o el trastorno bipolar, pueden preceder a

su aparición y contribuir a su desarrollo. El artículo cita un metaanálisis de estudios longitudinales que identificó el insomnio como predictor significativo del desarrollo posterior de depresión, ansiedad, abuso de alcohol y psicosis. También describe mecanismos biológicos implicados, como el aumento de cortisol y de procesos inflamatorios asociados a la privación de sueño: un ensayo aleatorizado con personas mayores de 60 años, citado en el artículo, encontró que quienes padecían insomnio experimentaban un incremento del ánimo depresivo tres veces superior al de quienes dormían con normalidad tras inducirles una respuesta inflamatoria leve. El texto señala además que los trastornos del ritmo circadiano afectan aproximadamente al 3 % de la población adulta y que la apnea obstructiva del sueño afecta a más del 32 % de la población adulta en Estados Unidos. Respecto al tratamiento, la revista destaca que la terapia cognitivo-conductual para el insomnio (TCC-I) cuenta con más de cien ensayos clínicos aleatorizados que respaldan su eficacia y está recomendada como tratamiento de primera elección por la Asociación Americana de Medicina del Sueño y el Colegio Americano de Médicos.

Fuente: Monitor on Psychology (American Psychological Association)

Publicaciones científicas recientes

Arjol, D., Mora-Simón, S., Rodríguez-Sánchez, E., Gómez-Marcos, M. A., García-Ortiz, L., Maderuelo-Fernández, J. A., Lugones-Sánchez, C., y Unzueta-Arce, J. (2026). Propiedades psicométricas del Montreal Cognitive Assessment (MoCA) en adultos españoles. *Psicothema*, 38(3), 161-172.

DOI: [10.70478/psicothema.2026.38.15](https://doi.org/10.70478/psicothema.2026.38.15)

Hallazgo: El estudio, publicado en la revista *Psicothema* y realizado por un equipo del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, analizó la estructura interna del Montreal Cognitive Assessment (MoCA) en una muestra comunitaria de 1.767 adultos españoles de entre 18 y 89 años, reclutados en centros de atención primaria y sin deterioro cognitivo diagnosticado. Los modelos factoriales teóricos previamente propuestos para el MoCA no mostraron un ajuste adecuado a los datos. Mediante validación cruzada y teoría de respuesta al ítem, los autores identificaron una solución alternativa de 12 ítems organizados en dos factores correlacionados, denominados Mnésico y Múltiple, con un ajuste estadístico excelente (CFI = .991; RMSEA =

.019) y una correlación latente de $r = .63$ entre ambos factores. La versión abreviada de 12 ítems mostró una alta concordancia con la puntuación total del test (CCI = .96) y un acuerdo sustancial en la clasificación dicotómica de deterioro cognitivo ($k = .84$). El MoCA también mostró asociaciones coherentes con variables externas como la edad, el nivel educativo y el riesgo vascular.

Implicación clínica: Los autores concluyen que el MoCA presenta una estructura de dos factores en población española y recomiendan priorizar una interpretación dimensional de sus resultados en lugar de basarse únicamente en la puntuación total, dado que la versión abreviada de 12 ítems mostró una precisión de clasificación comparable a la escala completa. El estudio se enmarca en una muestra comunitaria de atención primaria sin deterioro cognitivo diagnosticado, por lo que sus conclusiones se refieren a esta población y no necesariamente a personas con deterioro cognitivo ya diagnosticado.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Protocolos estructurados de primeros auxilios psicológicos para el ámbito escolar:** Guías profesionales, elaboradas por colegios oficiales de psicología, que organizan en pasos secuenciales la intervención inmediata tras un suceso potencialmente traumático en un centro educativo: evaluación del entorno y de quién necesita atención prioritaria, escucha activa y validación emocional, técnicas de respiración y anclaje para estabilizar a la persona afectada, priorización de necesidades, conexión con la red de apoyo, psicoeducación sobre las reacciones esperables y, si es necesario, derivación a servicios especializados de salud mental.

Prioridades del día

Formación en primeros auxilios psicológicos para el ámbito escolar

A raíz de la guía publicada por el COP Asturias, puede ser útil valorar la incorporación de formación específica en primeros auxilios psicológicos y en el protocolo R.E.S.C.A.T.E. para quienes trabajan con población infantojuvenil,

especialmente de cara a situaciones de emergencia o duelo en el entorno educativo.

Accesibilidad cognitiva en la práctica clínica

Con la aprobación del nuevo reglamento, puede ser relevante revisar si los materiales informativos, el lenguaje empleado en las sesiones y la documentación dirigida a pacientes con dificultades de comprensión – personas mayores, con discapacidad intelectual o deterioro cognitivo– cumplen ya criterios de lectura fácil y lenguaje claro.

Cribado cognitivo y estructura del MoCA

A la luz del nuevo estudio de validación publicado en Psicothema, puede ser oportuno explorar la interpretación por factores (Mnésico y Múltiple) del MoCA, y no solo la puntuación total, al utilizar este instrumento en la práctica neuropsicológica con población española.